



Organización
Mundial de la Salud



MRBMUN
OMS
2026

Índice

Libro I

Capítulo I : Carta de la secretaria general y académica

Capítulo II : Carta de la mesa directiva

Libro II

Capítulo III : Matriz

Capítulo IV: Atribuciones del comité

Capítulo V: Modalidad del comité

Libro III

Capítulo V: Tópicos, antecedentes, situación actual y puntos a considerar

Capítulo VI: Qarmas (Preguntas al Delegado)

Libro IV

Capítulo VII: Referencias Bibliográficas



Libro I

Capítulo I: Carta de la secretaria general y académica

Estimados delegados, para nosotros es un gran honor que hayan decidido participar en la primera edición virtual de MRBMUN 2026, sabemos que aprenderán mucho, se divertirán y pondrán a prueba sus capacidades para debatir y resolver conflictos, la misión de MRBMUN es impulsar los modelos de naciones unidas globalmente a través de eventos como este, como primera edición presenciarán el inicio de algo que esperemos sea mucho más grande año tras año, es un reto para todos, pero sabemos que juntos podremos construir un MUN excelente. Recuerden, si tienen alguna duda con respecto al manejo de procedimientos, o con cualquier otro aspecto del debate, tanto sus mesas directivas como nosotros estamos a disposición para resolver cualquier pregunta que tengan, sabemos que darán lo mejor de sí mismos, se divertirán mucho y aprenderán sobre diplomacia global, tomando en cuenta que de momento somos un modelo pequeño, hemos tenido que asumir la presidencia de ciertos comités, sin embargo esta medida no elimina nuestra presencia en el modelo de manera general, esperamos que puedan participar en las próximas ediciones de MRBMUN tanto virtual como presencial.

Miguel Elías Sudano.

Secretario General

María José Neira

Secretaría Académica

Capítulo II : Carta de la mesa directiva Estimados Delegados...

Estimados Faculties, delegados y demás delegaciones lectoras, reciban un cordial y afectuoso saludo por parte de la mesa directiva de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se les otorga una cálida bienvenida a la Primera Edición Virtual del Colegio Monterrosales (MRBMUN 2026)

Es un honor para nosotras darles la más cordial bienvenida al **Comité de la OMS**. Nos llena de entusiasmo que hayan elegido formar parte de este espacio, y confiamos plenamente en que estos próximos dos días de debate serán enriquecedores y transformadores para todos.

El equipo de la mesa ha puesto gran dedicación en la elaboración de la guía de estudio, con la esperanza de que la encuentren clara, útil y que les sirva como herramienta esencial para profundizar en los temas que abordaremos. Con su preparación, compromiso y creatividad, estamos seguras de que el nivel de debate alcanzará estándares excepcionales.

Sabemos que algunos de ustedes quizás estén participando por primera vez en un modelo de este tipo, sin embargo, la mesa estará siempre a su lado para guiarlos, apoyarlos y ayudarlos a desenvolverse con seguridad. Valoramos profundamente el trabajo en equipo, la defensa firme de sus posturas y la capacidad de escuchar y negociar, pues estos son pilares fundamentales para el éxito dentro de este comité.

Más allá de la intensidad del debate, queremos que disfruten al máximo de esta experiencia. Aprovechen cada instante para aprender, generar nuevas amistades y llevarse recuerdos valiosos. Recuerden que más allá de un posible reconocimiento, el verdadero premio se encuentra en el crecimiento personal, en el desarrollo de sus habilidades y en el camino que recorren dentro de este modelo.

¡Les damos la bienvenida con mucha ilusión y estamos ansiosos por verlos brillar en el debate!

Atentamente,

La Mesa Directiva de la Organización Mundial de la Salud

Luciana Patiño.
Co-Presidenta.

Sofia Dávila
Presidenta

María José Neira
Moderadora

Libro II

Capítulo III : Matriz

Arabia Saudita	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	Chile	Reino Unido
Colombia	Corea del Sur	España	Estados Unidos	Etiopía	Filipinas	Sudáfrica
Francia	India	Japón	México	Nigeria	Nueva Zelanda	Suecia

Capítulo IV: Atribuciones del comité

Atribuciones del comité

Potestades de la OMS

- Ofrecer liderazgo en temas cruciales para la salud y participar en alianzas cuando se requieran actuaciones conjuntas.
- Determinar las líneas de investigación y estimular la producción, difusión y aplicación de conocimientos valiosos.
- Establecer normas y promover y seguir de cerca su aplicación en la práctica.
- Formular opciones de política que aúnen principios éticos y de fundamento científico.
- Prestar apoyo técnico, catalizar el cambio y crear capacidad institucional duradera.
- Velar por la erradicación de todo tipo de enfermedades de alto, medio y bajo riesgo.
- Conseguir un sistema de salud cuyo servicio sea asequible y de calidad.
- Mantener la ética, moral y principios de los procedimientos médicos velando por la seguridad y salud.
- Seguir de cerca la situación en materia de salud y determinar las tendencias sanitarias.

Procedimientos de la OMS:

- Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE): La OMS desarrolla y mantiene la CIE, que es un sistema de clasificación utilizado para codificar y registrar enfermedades, lesiones y causas de muerte. Esta clasificación es utilizada por los profesionales de la salud en todo el mundo para fines de diagnóstico y estadísticas de salud.
- Listado de Verificación Quirúrgica: La OMS ha desarrollado un listado de verificación quirúrgica que se utiliza para mejorar la seguridad de los pacientes durante los procedimientos quirúrgicos. Este listado ayuda a garantizar que se realicen los pasos y controles necesarios antes, durante y después de una cirugía para prevenir eventos adversos.
- Guías de práctica clínica: La OMS proporciona directrices basadas en la evidencia para el manejo y tratamiento de diversas enfermedades y condiciones de salud. Estas guías están diseñadas para ayudar a los profesionales de la salud a tomar decisiones informadas y brindar una atención de calidad.
- Procedimientos de bioseguridad: La OMS establece normas y procedimientos para garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. Esto incluye pautas para el lavado de manos, el uso adecuado de equipos de protección personal y la gestión segura de desechos médicos.

Objetivos

- Fortalecer los distintos sistemas de salud del mundo, y especialmente del mundo en desarrollo.
- Conseguir que la salud ocupe un lugar privilegiado en las políticas de salud de los países.
- Establecer estrategias sanitarias que respondan a las diversas y cambiantes necesidades de los países.
- Movilizar mayores recursos para el sector salud en los países del mundo no desarrollado.
- Mejorar las estrategias de medición y obtención de datos sanitarios en el mundo entero.

Atribuciones

- *Establecer políticas y normas:* La OMS tiene la responsabilidad de establecer políticas y normas en asuntos de salud, así como proponer convenciones, acuerdos y reglamentos en relación con la salubridad internacional.
- *Promover la cooperación:* La OMS promueve la cooperación entre agrupaciones científicas y profesionales que contribuyan al mejoramiento de la salud.
- *Configurar la agenda de investigaciones en salud:* La OMS tiene la tarea de configurar la agenda de las investigaciones en salud y articular opciones de política basadas en la evidencia.
- *Prestar apoyo técnico:* La OMS brinda apoyo técnico a los países en asuntos de salud.
- *Vigilar las tendencias sanitarias mundiales:* La OMS monitorea y analiza las tendencias sanitarias mundiales para identificar y abordar problemas de salud.
- *Fortalecer los sistemas de salud:* La OMS trabaja en estrecha colaboración con otros organismos involucrados en la salud para fortalecer los sistemas de salud.

Compromisos con las naciones

- *Colaboración reforzada:* La OMS y el Fondo Mundial han anunciado un nuevo Marco Estratégico de Colaboración para fortalecer su colaboración en beneficio de los países.
- *Prevención, preparación y respuesta ante pandemias:* Los líderes mundiales han expresado un compromiso histórico en la Asamblea General de las Naciones Unidas para prevenir, prepararse y responder ante futuras pandemias.
- *Acuerdo sobre Pandemias:* La OMS está trabajando en la negociación de un acuerdo internacional para prevenir, prepararse y responder ante las pandemias.
- *Fortalecimiento de la OMS:* Los países invierten en asegurar que la OMS tenga los recursos necesarios para desempeñar su papel en respuesta a las pandemias y en la implementación de soluciones integradas para los desafíos sanitarios mundiales.

Cooperación trilateral: La OMS, la Organización Mundial de la Propiedad Industrial (OMPI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) han renovado su compromiso de apoyar soluciones integradas para enfrentar los desafíos sanitarios mundiales.

Comités y Subdivisiones de la OMS:

- Comité de expertos de la OMS en patrones biológicos: La comisión de patrones biológicos fue fundada el 31 de octubre del año 1997 en el aniversario número 50 de la OMS. Sus atribuciones son el estudio, control y protección de muestras y datos de tipo biológicos relacionados con la salud. Además de mantener y desarrollar los controles, procedimientos y demás al momento de tratar con evidencias biológicas.
- Comisión OMS de salud y medio ambiente: La subdivisión creada a inicios del año 1990 tiene dentro de sus potestades y funciones el estudio de la relación del medio ambiente con la salud, el desarrollo de nuevos riesgos y enfermedades para el ser humano; como este influye y cómo trabajar estas problemáticas.
- Comisión de asuntos administrativos, financieros y jurídicos de la OMS: Esta comisión formada el 17 de mayo del año 1957 tiene como objetivo el sustento económico de la organización mundial de la salud, administrar sus fondos presupuestarios, dirigir los asuntos comerciales de la misma y mantener orden todo tipo de posición y requisito legal. Esta debe supervisar e investigar que todos los procedimientos realizados sean legal y constitucionalmente correctos a nivel internacional y de cada país.

Documentos Requeridos

Los documentos solicitados a continuación, son estrictamente obligados a entregar, exceptuando los materiales audiovisual y las enmiendas que se consideran opcionales:

- **Papel de Posición oficial:** Se trata de un documento que detalla información específica del país representado, incluyendo datos oficiales tales como nombre oficial de la Nación, la capital, presidente, forma de gobierno, idioma oficial, superficie, población, PIB, entre otros aspectos.

Además se expone la posición Oficial de la delegación respecto al tópico planteado, así como las acciones realizadas y opiniones emitidas. Por último, en este documento se debe agregar las soluciones que plantea la delegación para el tópico, siendo imperativo adherirse a esta postura oficial.

- **Hoja de Trabajo:** Es el documento final a presentar dentro del comité y tópico, en el mismo serán presentadas las propuestas de cada delegación en un formato de puntos y subpuntos. En el mismo, los delegados deberán redactar en el tiempo estipulado que comande la Mesa Directiva, sus propuestas para la resolución del tópico.

Dentro del documento se podrán emplear dos dinámicas, la división de bloques o un bloque único (todo el comité). En la primera, al existir dos bloques, ambos deberán ser presentados al comité como hoja de trabajo.

En el caso de la existencia de un bloque único, solo deberán corregir las propuestas y especificarlas, dados los planteamientos de la mesa directiva, así mismo en ambas dinámicas se deberá colocar el formato oficial dado por la Mesa Directiva. Una vez sea aprobada por la misma, será presentada ante el comité por un tiempo no mayor a 4 minutos, posteriormente serán dados 3 puntos de información. Finalmente, la hoja será sometida a una votación por lista mediante una moción, una vez haya sido aprobada, quedará concluida el comité y/o tópico.

Materiales Audiovisuales (No obligatorios): Los materiales audiovisuales son la presentación de una solución de manera organizada, de la forma que facilitan la presentación de ideas y propuestas de manera creativa, a través de presentaciones de diapositivas.

La delegación debe enviar el material audiovisual al correo que se adjuntará durante los dos días de debate, posterior a eso, la mesa se encargará de revisar, corregir y aprobar el material para ser presentado ante el foro.

Modalidad

El comité de la Organización Mundial de la Salud, al igual que otros órganos conocidos por su carácter «regular», opera mediante un sistema de lista de oradores. Este procedimiento se inicia mediante una moción presentada al comienzo de la primera sesión del modelo, permitiendo que todas las delegaciones interesadas puedan incorporarse a la misma, ya sea a solicitud de la mesa o mediante una nota parlamentaria. En su turno, las delegaciones podrán expresar sus posiciones ante el foro en un tiempo limitado, el cual podrá ser ampliado en caso de que se apruebe dicha extensión; los establecimientos y preguntas se deben llevar a cabo de manera formal y utilizando únicamente la tercera persona. Queda totalmente prohibido el uso de la segunda y primera persona dentro del comité, así como también el uso de lenguaje obsceno o vulgar (Las muletillas del estilo "tipo" u "o sea" no son recomendadas dentro del comité se pueden reemplazar por la expresión "es decir"). Por otro lado, estará en potestad del comité pedir o no la apertura de caucus simples/moderados y round robins para agilizar el debate.



Organización
Mundial de la Salud

Tópico A: Impacto económico y social de la obesidad en México

MRBMUN 2026

Tópico A: Impacto económico y social de la obesidad en México

Antecedentes

La obesidad en México es el resultado de un proceso histórico complejo que se ha desarrollado durante varias décadas y que combina transformaciones económicas, sociales, culturales y tecnológicas. Desde mediados del siglo XX, el país experimentó una transición nutricional marcada por el abandono progresivo de dietas tradicionales basadas en alimentos frescos, granos, vegetales y preparaciones caseras, hacia patrones alimentarios caracterizados por un alto consumo de productos industrializados, grasas saturadas, azúcares añadidos y bebidas calóricas. Este cambio se intensificó a partir de los años 80 y 90, cuando la apertura comercial y la globalización facilitaron la entrada masiva de alimentos ultraprocesados y cadenas de comida rápida, que encontraron en México un mercado amplio y altamente receptivo.

La urbanización acelerada también desempeñó un papel fundamental. Las ciudades crecieron de manera desordenada, reduciendo los espacios públicos destinados a la actividad física y fomentando estilos de vida más sedentarios. Las largas jornadas laborales, los desplazamientos extensos y la falta de tiempo para preparar alimentos saludables contribuyen a la adopción de opciones rápidas y calóricas. Paralelamente, la industria de bebidas azucaradas consolidó su presencia en el país, convirtiendo a México en uno de los mayores consumidores de refrescos del mundo. La publicidad dirigida a niños, la disponibilidad masiva de estos productos y su bajo costo reforzaron hábitos alimentarios poco saludables desde edades tempranas.

A principios del siglo XXI, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) comenzó a documentar un incremento sostenido en la prevalencia de sobrepeso y obesidad tanto en adultos como en niños. En 2013, la Secretaría de Salud declaró formalmente la obesidad como una epidemia nacional, mientras organismos internacionales como la OMS y la OCDE sitúan a México entre los países con mayores tasas de obesidad infantil y adulta. Este fenómeno no solo afecta la salud individual, sino que también tiene profundas implicaciones económicas, sociales y culturales, convirtiéndose en uno de los desafíos más importantes para el desarrollo sostenible del país.

Desarrollo del Conflicto

El conflicto relacionado con la obesidad en México es multidimensional y se sostiene sobre una red de factores estructurales que interactúan entre sí, generando un problema complejo y difícil de abordar. En primer lugar, los factores económicos y comerciales han permitido que la industria alimentaria (tanto nacional como transnacional) consolide un mercado altamente rentable basado en productos ultraprocesados de bajo costo y alto contenido calórico.

Estos productos suelen ser más accesibles económicamente que alimentos frescos, especialmente en zonas urbanas marginadas, donde la disponibilidad de frutas, verduras y proteínas de calidad es limitada. La publicidad masiva, la presencia dominante de tiendas de conveniencia y la falta de regulación efectiva han permitido que estos productos se integren profundamente en la dieta cotidiana de millones de personas.

La desigualdad social y territorial agrava el problema. Las comunidades de bajos ingresos enfrentan mayores barreras para acceder a alimentos nutritivos y espacios seguros para la actividad física. En muchas zonas, la inseguridad, la falta de parques, la ausencia de transporte público eficiente y la precariedad laboral reducen aún más las oportunidades de movilidad y recreación. Esto genera un círculo vicioso en el que la pobreza y la obesidad se refuerzan mutuamente.

La cultura alimentaria mexicana, aunque rica y diversa, también ha sido transformada por la modernización. El consumo de comida rápida, frituras, botanas y bebidas azucaradas se ha normalizado, especialmente entre niños y adolescentes. Las largas jornadas laborales y la falta de tiempo para cocinar han impulsado la preferencia por alimentos listos para consumir, que suelen ser más calóricos y menos nutritivos. A esto se suma la influencia de la industria alimentaria en políticas públicas, que en ocasiones ha retrasado reformas, suavizado regulaciones o promovido campañas que minimizan los riesgos de sus productos.

El sistema de salud enfrenta una carga creciente debido a las enfermedades derivadas de la obesidad, como diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardiovasculares. La atención médica, hospitalización y medicamentos representan un gasto significativo para el Estado, afectando la sostenibilidad financiera del sector público. Además, la obesidad impacta la productividad laboral mediante el ausentismo, la disminución del rendimiento y el aumento de incapacidades, lo que genera pérdidas económicas tanto para empresas como para el país en su conjunto.

Situación Actual

México enfrenta actualmente una de las crisis de obesidad más graves del mundo. Según datos recientes de ENSANUT y la OCDE, más del 75% de los adultos presentan sobrepeso u obesidad, y uno de cada tres niños vive con obesidad infantil. La obesidad representa cerca del 9% del gasto total en salud, mientras que la diabetes tipo 2 se mantiene como una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país. Esta situación ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional, impulsando la implementación de diversas políticas públicas.

Entre las medidas más destacadas se encuentra el etiquetado frontal de advertencia, implementado en 2020, que obliga a los productos con exceso de calorías, azúcares, grasas y sodio a incluir sellos visibles. Esta política ha sido reconocida internacionalmente como una de las más avanzadas en materia de salud pública.

Asimismo, el impuesto especial a bebidas azucaradas ha logrado reducir parcialmente su consumo, aunque su impacto varía según el nivel socioeconómico. También se han establecido lineamientos para limitar la venta de alimentos no saludables en escuelas, aunque su cumplimiento es irregular.

Diversas campañas de educación nutricional buscan promover hábitos saludables, pero enfrentan barreras culturales, económicas y estructurales. Organismos como UNICEF, OMS y FAO colaboran con el gobierno mexicano en programas de prevención, especialmente en comunidades vulnerables. Sin embargo, a pesar de estos avances, la obesidad continúa aumentando. La pandemia de COVID-19 agravó la situación al incrementar el sedentarismo, el estrés y el consumo de alimentos ultraprocesados.

Puntos a Considerar

- Costo económico de la obesidad para el sistema de salud.
- Impacto en la productividad laboral y ausentismo.
- Publicidad dirigida a menores y su regulación.
- Acceso desigual a alimentos saludables.
- Educación nutricional en escuelas y comunidades.
- Impacto en grupos vulnerables (niños, mujeres, zonas rurales).
- Rol de la industria alimentaria en la prevención.

QARMAs (Preguntas al Delegado)

1. ¿Cómo puede México equilibrar el derecho a la alimentación con la necesidad de regular productos dañinos?
2. ¿Qué estrategias propone su delegación para reducir la obesidad infantil en zonas vulnerables?
3. ¿Debería la industria alimentaria asumir responsabilidad económica por los daños a la salud pública?
4. ¿Qué políticas públicas pueden incentivar estilos de vida activos en zonas urbanas?
5. ¿Cómo puede la OMS apoyar a México en programas de prevención y educación nutricional?



Organización
Mundial de la Salud

Tópico B: “Salud mental en adolescentes en la era digital”

MRBMUN 2026

Tópico B: “Salud mental en adolescentes en la era digital”

Antecedentes

La salud mental de los adolescentes ha sido un tema de preocupación desde hace décadas, pero la llegada de la era digital transformó radicalmente el panorama. A partir de los años 2000, el acceso masivo a internet, teléfonos inteligentes y redes sociales modificó profundamente la forma en que los jóvenes se relacionan, construyen su identidad y procesan información. Las redes sociales introdujeron dinámicas inéditas, como la comparación social constante, la búsqueda de validación mediante “likes” y comentarios, la exposición a estándares irreales de belleza y éxito, y el acceso ilimitado a contenido emocionalmente intenso. Estas plataformas se convirtieron en espacios donde los adolescentes experimentan tanto apoyo como vulnerabilidad.

La adolescencia es una etapa crítica del desarrollo emocional, caracterizada por cambios hormonales, búsqueda de identidad, necesidad de pertenencia y sensibilidad a la opinión de los demás. En este contexto, las redes sociales funcionan como escenarios donde los jóvenes negocian su autoestima, su imagen corporal y su sentido de valor personal. A partir de 2010, diversos estudios comenzaron a mostrar correlaciones entre el uso excesivo de redes sociales y el aumento de ansiedad, depresión, trastornos alimentarios y autolesiones. Paralelamente, el ciberacoso emergió como una forma de violencia persistente, difícil de detectar y con consecuencias psicológicas profundas.

Organismos como la OMS, UNICEF y la APA han advertido que la salud mental adolescente debe considerarse una prioridad global, especialmente en un mundo donde la digitalización avanza más rápido que la regulación, la educación emocional y la capacidad de las familias para acompañar a los jóvenes en este entorno.

Desarrollo del conflicto

El conflicto central surge de la interacción entre tecnología, salud mental, regulación insuficiente y dinámicas sociales que afectan directamente el bienestar emocional de los adolescentes. Los algoritmos de las plataformas digitales están diseñados para maximizar el tiempo de uso, priorizando contenido que genera reacciones intensas como indignación, tristeza, miedo o euforia. Esto expone a los adolescentes a información que puede distorsionar su percepción del mundo y de sí mismos, afectando su estabilidad emocional.

El ciberacoso y la violencia digital representan otro eje del conflicto. El anonimato, la inmediatez y la posibilidad de viralización facilitan agresiones que pueden ser constantes y devastadoras. El ciberacoso afecta la autoestima, el rendimiento escolar y puede desencadenar depresión o ideación suicida. La adicción digital también se ha convertido en un fenómeno creciente: el diseño de las plataformas busca generar dependencia mediante recompensas intermitentes, lo que afecta el sueño, la concentración, la regulación emocional y la interacción social presencial.

La presión social y la autoimagen se ven profundamente influenciadas por las redes sociales. Los adolescentes están expuestos a estándares irreales de belleza, éxito y estilo de vida, lo que puede generar ansiedad, insatisfacción corporal y trastornos alimentarios. A esto se suma la falta de regulación internacional. Las plataformas operan globalmente, pero no existe un marco regulatorio uniforme que proteja a menores, y la responsabilidad de las empresas tecnológicas sigue siendo un tema de debate.

La brecha generacional agrava el conflicto. Muchos padres, docentes y autoridades no comprenden completamente el entorno digital, lo que dificulta la prevención y la intervención temprana. Además, la estigmatización de la salud mental en muchas culturas impide que los adolescentes busquen ayuda cuando la necesitan. En conjunto, estos factores crean un conflicto complejo donde derechos fundamentales como la libertad de expresión, la privacidad y la protección de menores convergen en un entorno que evoluciona más rápido que las políticas públicas.

La salud mental adolescente enfrenta hoy una crisis global. Diversos estudios muestran un aumento significativo de ansiedad y depresión en jóvenes de 12 a 18 años, así como un crecimiento de trastornos de la conducta alimentaria influenciados por redes sociales. El ciberacoso ha aumentado, especialmente en plataformas de mensajería instantánea, donde los ataques pueden ser constantes y difíciles de rastrear. Los adolescentes están expuestos a contenido dañino como autolesiones, violencia, retos peligrosos o desinformación, lo que afecta su bienestar emocional y su percepción de seguridad.

El uso nocturno de dispositivos ha generado alteraciones del sueño, que a su vez afectan la regulación emocional, el rendimiento académico y la salud física. La dependencia digital se ha convertido en un fenómeno común, afectando la capacidad de los jóvenes para concentrarse, socializar presencialmente y manejar el estrés. La pandemia de COVID-19 intensificó estos problemas al aumentar el tiempo frente a pantallas y reducir las interacciones sociales presenciales.

Organismos internacionales han respondido con diversas iniciativas. UNICEF junto con la OMS promueve programas de alfabetización digital, bienestar emocional y políticas de protección infantil en línea. Asimismo, la OMS incluye la salud mental adolescente como prioridad en su Plan de Acción de Salud Mental. La UNESCO impulsa programas educativos para docentes y familias sobre uso responsable de tecnología. Algunos gobiernos han comenzado a regular algoritmos, limitar publicidad dirigida a menores y exigir transparencia a plataformas digitales.

Sin embargo, la velocidad del desarrollo tecnológico supera la capacidad de regulación. El desafío actual consiste en construir entornos digitales seguros, promover educación emocional, fortalecer los servicios de salud mental en escuelas y garantizar que los adolescentes tengan acceso a apoyo psicológico accesible, oportuno y libre de estigma. La salud mental en la era digital es un tema que requiere cooperación internacional, políticas innovadoras y un enfoque centrado en los derechos de los jóvenes.

Puntos a Considerar

- Impacto de los algoritmos en la salud mental adolescente.
 - Regulación del contenido dañino en redes sociales.
 - Acceso a servicios de salud mental en escuelas.
 - Educación digital para padres y docentes.
 - Ciberacoso y mecanismos de denuncia.
 - Promoción de espacios seguros en línea.
 - Estigmatización de la salud mental en distintas culturas
-

QARMAs (Preguntas al Delegado)

1. ¿Cómo puede la OMS promover entornos digitales seguros para adolescentes?
2. ¿Qué medidas deben tomar los Estados para regular algoritmos que afectan la salud mental?
3. ¿Cómo garantizar acceso equitativo a servicios psicológicos en escuelas?
4. ¿Qué estrategias propone su delegación para combatir el ciberacoso?
5. ¿Cómo equilibrar libertad de expresión y protección de menores en redes sociales?
6. ¿Deberían las plataformas digitales ser responsables legalmente por daños psicológicos a menores?

Libro IV

Capítulo VII: Referencias Bibliográficas

Referencias Bibliográficas

TÓPICO A:

- Organización Mundial de la Salud. (2021). Obesity and overweight. OMS.
- Organización Panamericana de la Salud. (2020). Obesidad en las Américas: situación epidemiológica y políticas públicas. OPS.
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2020). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2020. INSP.
- FAO. (2019). Panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en México. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Barquera, S., Hernández-Barrera, L., Trejo-Valdivia, B., & Rivera-Dommarco, J. (2018). Obesidad en México: epidemiología y políticas de salud. Salud Pública de México.
- UNICEF México. (2022). Nutrición y salud infantil en México. UNICEF.

TÓPICO B:

- Organización Mundial de la Salud. (2021). Adolescent mental health. OMS
- UNICEF. (2021). The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health. UNICEF.
- American Psychological Association. (2020). Digital media use and mental health: APA report. APA.
- UNESCO. (2020). Youth and digital citizenship: Understanding online behavior. UNESCO